

8 その他の胸膜腫瘍

other pleural tumors

到達目標

- 胸膜腫瘍の疾患名を挙げることができる
- 孤立性線維性腫瘍 (SFT) について疾患の概説ができる

病因・病態・疫学

胸膜腫瘍は、胸膜の中皮細胞または間葉系細胞を起源とする腫瘍性疾患の総称である。悪性胸膜中皮腫を除くと、個々の胸膜腫瘍はまれな疾患であり、かつ良性腫瘍、境界悪性腫瘍、悪性腫瘍まで多彩である。その中でも比較的多い胸膜腫瘍は、孤立性線維性腫瘍 (solitary fibrous tumor : SFT) である。それ以外は、石灰化線維性腫瘍、腺腫様腫瘍、胸膜胸腺腫、デスモイド腫瘍、脂肪腫、脂肪肉腫、血管肉腫など、いずれも極めてまれな疾患である¹⁾。以下比較的多い SFT を中心に解説する。

SFT は胸膜の間葉系細胞由来の腫瘍であり、発症原因となる環境因子、遺伝因子は不明である。腫瘍は中皮腫が壁側胸膜から発生するのと異なり、臓側胸膜から発生することが多い。発症頻度に男女差はなく、60～70 歳代に多い。多くは良性腫瘍であるが、約 10～20% は悪性である²⁾。

症 候

SFT は他の胸膜腫瘍と同様に、通常無症候性で偶然に胸部 X 線写真、胸部 CT で発見されることが多く、過半数が健診発見である。巨大腫瘍像を呈することもある。良性でも腫瘍が大きい症例や悪性の症例では、胸痛、呼吸困難などの症状がみられることもある。また良性、悪性にかかわらず、SFT 特有の腫瘍随伴症候群を示すことがある。約 10～20% でパチ指や骨関節炎症状 (肺性肥大性骨関節症) を認める。また 5% 以下ではあるが、腫瘍によるインスリン様成長因子 II (IGF-II) の分泌により、再発性低血糖症状 (Doege-Potter 症候群) を呈する³⁾。

診断・検査

SFT は胸部 X 線写真、胸部 CT で容易にその存在を確認することができる。胸部 CT では境界明瞭、非浸潤性の腫瘍として認められる。造影効果は強く、腫瘍内部は不均一に造影される。巨大化すると 30% に石灰化を認める (図 1)。MRI は腫瘍と縦隔や大血管との関連性を確認することに有用であり、¹⁸F-FDG-PET/CT 検査では低集積像を示し、高集積像を示すことの多い悪性疾患との鑑別に有用である⁴⁾。



図 1 孤立性線維性腫瘍の造影 CT 像 (68 歳、男性)

右胸腔を占拠する。境界明瞭で内部が不均一に造影され一部に石灰化を伴う巨大腫瘍を認める。一部エコーガイド下生検で SFT と診断された。

診断は術前の針生検などでなされるが、良性、悪性の鑑別も含めて、最終的には術後病理診断によって確定診断される。病理組織学的には、線維性の間質を背景に類円形核を有する紡錘形細胞の増殖を認め、腫瘍細胞の核分裂像が多い場合には悪性と診断される。免疫染色では、有茎性の場合、CD34、bcl-2、CD99 が陽性、cytokeratin、 α -SMA、S-100 が陰性の良性腫瘍であることが多い。再発することがあり、無茎性では悪性像を呈することがある³⁾。